

MATÉRIEL NÉCESSAIRE



IPG (Générateur d'Impulsions Implantables)

Fourni dans un emballage à usage unique sous forme de kit avec la configuration suivante :

- Un IPG modèle 2104 stérile avec thérapie désactivée
- Une clé dynamométrique stérile

CSL (dérivation du sinus carotidien)

Fourni dans un emballage à usage unique sous forme de kit avec la configuration suivante :

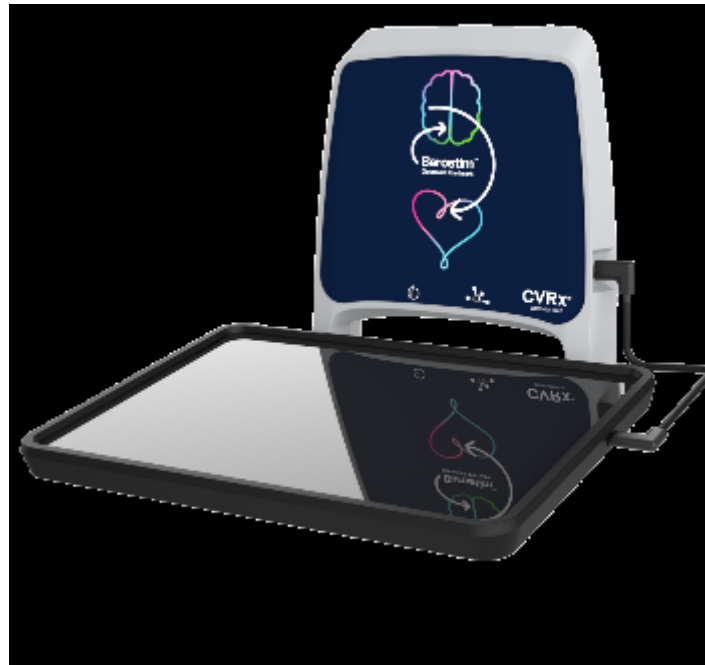


- Un CSL stérile – Modèle 1036
- Un outil d'implantation stérile

Programmeur

Livré en kit, dans un coffret, avec les composants suivants :

- Logiciel de programmation
- Interface de programmation – Modèle 9020
- Tablette avec cordon d'alimentation
- Câble USB-C



Modèle 9020

PRÉPARATION CHIRURGICALE

Préparation de la peau

Suivez les pratiques de préparation chirurgicale de la peau de votre établissement. Pensez à appliquer un agent efficace contre la flore cutanée typique.

Envisagez l'application d'une barrière cutanée imperméable pour minimiser le contact entre les composants implantés et la peau du patient.

6 | 900133-002 Rév. D IFU Procédures chirurgicales

Couverture antibiotique

Suivez les pratiques de couverture antibiotiques de votre établissement. Envisager une couverture antibiotique en période périopératoire si ce n'est pas la pratique actuelle. Envisagez une deuxième dose d'antibiotiques pendant la procédure d'implantation.

Emballage stérile

L'IPG, le CSL et l'outil d'implant sont fournis STÉRILES (par gaz d'oxyde d'éthylène) et à USAGE UNIQUE. La réutilisation de ce produit peut entraîner un dysfonctionnement, un événement indésirable ou la mort.

Les composants sont fournis dans un emballage stérile pour une introduction directe dans le champ opératoire. Inspectez soigneusement les emballages stériles avant de les ouvrir. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert, endommagé ou présente des signes de dommages ou de stérilité compromise.

Renvoyez le colis et/ou le contenu à CVRx.

N'ouvrez pas l'emballage s'il a été exposé à des températures extrêmes en dehors de la plage de température indiquée sur l'étiquette, ou si l'emballage ou le sceau de l'emballage est endommagé.

Renvoyez le colis, non ouvert, à CVRx.

Ne pas utiliser à compter de la date « À utiliser avant ». Renvoyez le paquet non ouvert à CVRx.

Avant d'ouvrir l'emballage IPG, utilisez le système de programmation pour vérifier la batterie IPG. Si la tension de la batterie signalée est inférieure à 2,85 V, renvoyez l'emballage, non ouvert, au CVRx.

Pour ouvrir le package, procédez comme suit :

1. Saisissez la languette et retirez le couvercle extérieur.
2. En utilisant une technique stérile, retirez le plateau intérieur.
3. Saisissez la languette du bac intérieur et retirez le couvercle intérieur pour exposer le contenu.
4. Retirez le produit.

Test d'interaction avec les appareils

Si les interactions problématiques ne peuvent pas être éliminées lors de l'implantation, le système Barostim doit être explanté. Il est recommandé de surveiller les interactions des patients après l'implantation et chaque fois que des modifications sont apportées à l'un ou l'autre des dispositifs. Si les interactions avec le dispositif qui se développent après l'implantation ne peuvent pas être éliminées, le Barostim IPG doit être programmé sur « OFF ». Vous trouverez ci-dessous des instructions pour effectuer des tests d'interaction avec l'appareil.

- Si un patient porte un appareil CRM (par exemple, un stimulateur cardiaque, un DAI ou un CRT-D), effectuez des tests d'interaction avec l'appareil une fois que l'IPG est dans la poche et avant que le patient ne sorte de l'anesthésie.
- Demandez au représentant des appareils CRM ou au technicien des appareils hospitaliers de :
- Maximisez la sensibilité des appareils CRM. Pour les appareils dotés d'une sensibilité automatique (par exemple, les DAI), programmez l'appareil pour qu'il stimule plus rapidement que la fréquence intrinsèque afin de garantir que l'appareil atteigne la sensibilité la plus élevée.

- Le cas échéant pour le dispositif CRM, comparer les critères de discrimination morphologique avec Barostim éteint et allumé.
- Testez les paramètres Barostim recommandés :

Pulse Width	Frequency	General Anesthesia	Local Anesthesia or Post-Operative
30 μ s	40 pps	20 mA (or highest within compliance)	Maximum before extraneous sensations
170 μ s	40 pps	12 mA	
500 μ s	40 pps	8 mA	

Si des interactions sont observées, enregistrez les informations dans le rapport récapitulatif de la session et atténuez-les en :

- Restauration de la sensibilité du dispositif CRM à la valeur programmée.
- Réduisez l'amplitude du Barostim jusqu'à ce que l'interaction ne se produise plus.

2 Procédure d'implantation

9 | 900133-002 Rév. D IFU Procédures chirurgicales

L'approche chirurgicale et les techniques d'implantation du système varieront selon les préférences du chirurgien implanteur. Les exigences pour une implantation correcte et sûre du système doivent inclure les éléments couverts dans cette section.

MISE À JOUR CLINIQUE

Sur la base de la base de données BeAT-HF PMA Amendment du 30 avril 2019, la position de l'implant pour la sonde du sinus carotidien (A-D, image ci-dessous) a été évaluée pour la réponse chronique par position. Comme le montre le tableau 1, les résultats sont cohérents quel que soit l'emplacement des sondes (A par rapport à B-D), ce qui soutient l'élimination de l'obligation de cartographie pendant l'implantation. Il est recommandé que l'emplacement de l'implant soit prioritaire à l'emplacement « A ». Dans les cas où l'implantation à l'emplacement « A » n'est pas souhaitable d'un point de vue anatomique, choisissez un emplacement aussi proche de « A » que l'anatomie le permet, en fonction de l'expérience du médecin implanteur. Dans la population d'utilisation prévue du BeAT-HF, 90 % des sujets avaient la sonde implantée en position A sur l'artère carotide. Le tableau 1 montre le pourcentage de sujets qui ont eu une réponse cliniquement pertinente à six mois dans le 6MHW (≥ 25 mètres), la qualité de vie (≥ 5 points) et/ou le sondage NT (≥ 10 % de réduction relative), ainsi que le pourcentage de sujets qui ont répondu à au moins un ou deux de ces critères d'évaluation. Les taux de réponse pour tous les critères d'évaluation étaient similaires, quelle que soit la position finale du leader.

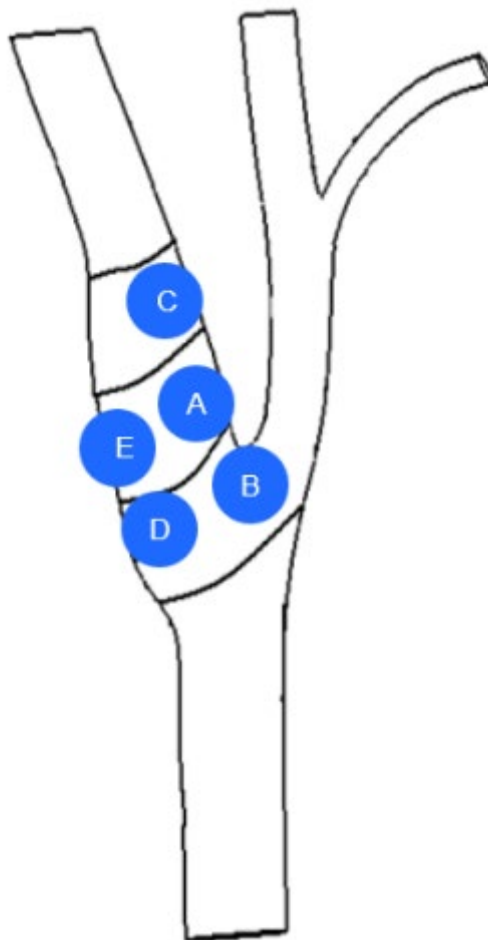


Tableau 1 : Réponse par emplacement du prospect chez les sujets d'utilisation prévue

	Emplacement du responsable A			Emplacement du responsable B-D		
Variable	N	Moyenne $\pm$ ET ou N (%)	Médian	N	Moyenne $\pm$ ET ou N (%)	Médian

	Emplacement du responsable A			Emplacement du responsable B-D		
			(Gamme)			(Gamme)
Répondeur 6MHW	103	72 (69,9%)	N / A	11	7 (63,6%)	N / A
Réponse QdV	104	73 (70,2%)	N / A	12	10 (83,3%)	N / A
NT-proBNP	104	58 (55,8%)	N / A	12	5 (41,7%)	N / A
Réponse >= 1	104	99 (95,2%)	N / A	12	11 (91,7%)	N / A
Réponse >= 2	104	77 (74,0%)	N / A	12	9 (75,0%)	N / A